ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

# NEFROLOGÍA

**90** preguntas de práctica

Medio Interno

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Nefrología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 05 · PARTE A: POR BLOQUES

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS** | | | | | |
| 1.09.1.013 | Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10, Q12, Q13 | Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9) |
| 1.09.1.020 | Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.1.023 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14, Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.1.024 | Urolitiasis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.025 | Uropatía obstructiva | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.003 | Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.2.004 | Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q11, Q12, Q13 | Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9) |
| 1.09.2.008 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.2.009 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q4 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.010 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.3.004 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.4.009 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.4.016 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.5.003 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| **BLOQUE 2: TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)** | | | | | |
| 1.09.1.007 | Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31, Q32, Q33, Q34 | Tomo 05 · 2.3 (Pág. 24) |
| 1.09.1.010 | SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q26, Q27, Q28, Q29, Q30 | Tomo 05 · 2.2 (Pág. 22) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.1.020 | Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.2.007 | Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q29, Q30 | Tomo 05 · 2.1 (Pág. 18) |
| 1.09.2.008 | Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q24, Q25, Q33, Q34, Q35, Q36 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.3.009 | Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 05 · 2.4 (Pág. 26) |
| 1.09.4.016 | Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q24, Q25 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 3: TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE** | | | | | |
| 1.09.1.001 | Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.09.1.002 | Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q51 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.003 | Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q52 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.005 | Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q40, Q41 | Tomo 05 · 3.1 (Pág. 31) |
| 1.09.2.006 | Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42, Q43, Q44 | Tomo 05 · 3.2 (Pág. 35) |
| 1.09.2.008 | Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q53, Q54 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.3.009 | Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q43, Q44 | Tomo 05 · 2.4 (Pág. 26) |
| 1.09.4.016 | Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38, Q39, Q40, Q41, Q47, Q48, Q49, Q50, Q53, Q54 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 4: SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS** | | | | | |
| 1.09.1.006 | Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58) |
| 1.09.1.018 | Proteinuria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.021 | Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q64, Q65, Q66 | Tomo 05 · 4.3 (Pág. 52) |
| 1.09.1.022 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57, Q58, Q59, Q60, Q62, Q63 | Tomo 05 · 4.1 (Pág. 46) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.2.001 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q61 | Tomo 17 · 17.3 (Pág. 13) |
| 1.09.2.013 | Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67, Q68, Q69, Q70, Q71 | Tomo 05 · 4.4 (Pág. 54) |
| 1.09.4.016 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q57, Q58, Q59, Q60, Q68, Q69, Q70, Q71 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 5: ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS** | | | | | |
| 1.09.1.001 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.09.1.004 | Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q84 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.005 | Bacteriuria asintomática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.008 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q78 | Tomo 09 · 9.21 (Pág. 77) |
| 1.09.1.009 | Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86 | Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69) |
| 1.09.1.011 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q87 | Tomo 05 · C.22 (Pág. 48) |
| 1.09.1.012 | Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q90 | Tomo 09 · 9.23 (Pág. 85) |
| 1.09.1.014 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q79, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |
| 1.09.1.015 | Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85 | Tomo 05 · 5.2 (Pág. 67) |
| 1.09.1.016 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q88 | Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71) |
| 1.09.1.017 | Progresión de la IRC | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.019 | Riñón poliquístico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.002 | Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q76 | Tomo 01 · 5.4 (Pág. 95) |
| 1.09.2.011 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71) |
| 1.09.2.012 | Pre eclampsia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.4.005 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: | GES | Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Completo** | | | |
| 1.09.4.016 | **Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)** | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Nefrología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 05 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.1.001 | Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.09.1.002 | Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q51 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.003 | Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q52 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.004 | Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q84 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.005 | Bacteriuria asintomática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.006 | Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58) |
| 1.09.1.007 | Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31, Q32, Q33, Q34 | Tomo 05 · 2.3 (Pág. 24) |
| 1.09.1.008 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q78 | Tomo 09 · 9.21 (Pág. 77) |
| 1.09.1.009 | Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86 | Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69) |
| 1.09.1.010 | SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q26, Q27, Q28, Q29, Q30 | Tomo 05 · 2.2 (Pág. 22) |
| 1.09.1.011 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q87 | Tomo 05 · C.22 (Pág. 48) |
| 1.09.1.012 | Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q90 | Tomo 09 · 9.23 (Pág. 85) |
| 1.09.1.013 | Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10, Q12, Q13 | Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9) |
| 1.09.1.014 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q79, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |
| 1.09.1.015 | Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85 | Tomo 05 · 5.2 (Pág. 67) |
| 1.09.1.016 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q88 | Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71) |
| 1.09.1.017 | Progresión de la IRC | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.1.018 | Proteinuria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.019 | Riñón poliquístico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.020 | Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17, Q35, Q36 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.1.021 | Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q64, Q65, Q66 | Tomo 05 · 4.3 (Pág. 52) |
| 1.09.1.022 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57, Q58, Q59, Q60, Q62, Q63 | Tomo 05 · 4.1 (Pág. 46) |
| 1.09.1.023 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14, Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.1.024 | Urolitiasis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.025 | Uropatía obstructiva | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.001 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q61 | Tomo 17 · 17.3 (Pág. 13) |
| 1.09.2.002 | Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q76 | Tomo 01 · 5.4 (Pág. 95) |
| 1.09.2.003 | Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.2.004 | Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q11, Q12, Q13 | Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9) |
| 1.09.2.005 | Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q40, Q41 | Tomo 05 · 3.1 (Pág. 31) |
| 1.09.2.006 | Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42, Q43, Q44 | Tomo 05 · 3.2 (Pág. 35) |
| 1.09.2.007 | Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q29, Q30 | Tomo 05 · 2.1 (Pág. 18) |
| 1.09.2.008 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q6, Q7, Q8, Q9, Q22, Q23, Q24, Q25, Q33, Q34, Q35, Q36, Q53, Q54 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.2.009 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q4 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.010 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.2.011 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71) |
| 1.09.2.012 | Pre eclampsia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.013 | Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67, Q68, Q69, Q70, Q71 | Tomo 05 · 4.4 (Pág. 54) |
| 1.09.3.004 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.3.009 | Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36, Q43, Q44 | Tomo 05 · 2.4 (Pág. 26) |
| 1.09.4.005 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |
| 1.09.4.009 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.4.016 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9, Q22, Q23, Q24, Q25, Q38, Q39, Q40, Q41, Q47, Q48, Q49, Q50, Q53, Q54, Q57, Q58, Q59, Q60, Q68, Q69, Q70, Q71, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.5.003 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS

PREGUNTA 1 1.09.1.024

**1. Un paciente ha presentado 5 episodios de litiasis uretral en los últimos años. ¿Cuál es la ateración metabólica más probable en este paciente?**

A) Hipercalciuria
B) Hiperoxaluria
C) Hiperuricosuria
D) Hipocitraturia
E) Hipercistinuria

PREGUNTA 2 1.09.1.025

**2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Uropatía obstructiva · 1.09.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Uropatía obstructiva. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 1.09.2.008

**3. Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardiaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156. mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO2: 20 mmHg. ¿Cuál de los siguientes fluidos se debe administrar en primer lugar?**

A) Suero glucosado al 5% ev
B) Suero fisiológico al 0,9% ev
C) Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
D) Agua por sonda nasogástrica
E) Sales de rehidratación oral

PREGUNTA 4 1.09.2.009

**4. [URGENCIA: Insuficiencia renal aguda obstructiva · 1.09.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insuficiencia renal aguda obstructiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 5 1.09.2.010

**5. Un paciente de 76 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, EVA; 9/10, de 6 horas de evolución, irradiado al flanco ipsilateral y asociado a fiebre, vómitos, hematuria y agitación psicomotora. Al examen físico presenta FC: 100x', con ritmo cardíaco irregular, en dos tiempos, PA: 120/70 mmHg y puñopercusión positiva a derecha. En sus exámenes se aprecian 100 glóbulos rojos por campo y 20 glóbulos blancos por campo, en el sedimento de orina. Destaca, además, electrocardiograma con fibrilación auricular y creatinina plasmática de 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:**

A) Quiste renal complicado
B) Urolitiasis
C) Pielonefritis aguda
D) Obstrucción ureteral por coágulos
E) Embolia renal

PREGUNTA 6 1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016

**6.** **Hombre de 72 años con antecedentes de cardiopatía coronaria y uso crónico de furosemida 40 mg/día por insuficiencia cardíaca compensada. Consulta por debilidad y astenia tras 3 días de transgresión dietética y gastroenteritis aguda con vómitos. Al examen: PA 90/60 mmHg, turgencia cutánea disminuida, ortostatismo positivo. Laboratorio: Creatinina 2.9 mg/dL (basal 1.1 mg/dL), BUN 68 mg/dL, Sodio sérico 135 mEq/L, Potasio sérico 3.3 mEq/L, Sodio urinario 38 mEq/L. ¿Cuál es el parámetro más confiable para confirmar si la falla renal es de origen prerrenal en este paciente?**

A) Fracción excretada de sodio (FeNa)
B) Fracción excretada de urea (FeUrea)
C) Sedimento urinario en fresco
D) Resonancia magnética renal con contraste
E) Prueba de furosemida intravenosa en bolo

PREGUNTA 7 1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016

**7.** **Mujer de 64 años ingresa a la Unidad de Paciente Crítico por shock séptico de foco abdominal. A las 24 horas de evolución en ventilación mecánica y noradrenalina, la diuresis acumulada en las últimas 8 horas es de 15 mL/hora (peso 60 kg). Exámenes muestran aumento de creatinina sérica desde 0.9 mg/dL al ingreso hasta 2.8 mg/dL hoy. Sedimento urinario: abundantes cilindros granulosos pigmentados pardos y células epiteliales tubulares aisladas. FeNa: 3.2%. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario de la falla renal?**

A) Hipoperfusión renal reversible sin daño estructural tubular
B) Necrosis tubular aguda isquémica y tóxica con pérdida de polaridad celular
C) Nefritis intersticial aguda alérgica por antibióticos
D) Glomerulonefritis membranoproliferativa rápidamente progresiva
E) Microangiopatía trombótica con anemia hemolítica microangiopática

PREGUNTA 8 1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016

**8.** **Hombre de 76 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, cólico, de 12 horas de evolución, asociado a anuria absoluta en las últimas 6 horas. Tiene antecedente de hiperplasia prostática benigna y nefrectomía izquierda hace 10 años por trauma. Al examen físico: abdomen blando, doloroso a la palpación en fosa ilíaca y flanco derecho, sin signos de peritonismo. Laboratorio: Creatinina 4.8 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial prioritaria?**

A) Iniciar hemodiálisis de urgencia inmediata por fístula
B) Administrar 2.000 mL de suero fisiológico en bolo para forzar diuresis
C) Solicitar ecografía renal urgente y descompresión de la vía urinaria
D) Indicar tratamiento con ácido acetilsalicílico y heparina de bajo peso molecular
E) Realizar biopsia renal percutánea de urgencia

PREGUNTA 9 1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016

**9.** **Mujer de 58 años, diabética en tratamiento con Metformina, consulta por cefalea y artromialgias para lo cual se automedicó con Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 7 días. Concomitantemente inició Losartán 50 mg/día indicado por su médico general por cifras tensionales limítrofes. Consulta por astenia y náuseas. Laboratorio: Creatinina sérica 3.1 mg/dL (basal de hace 2 semanas 0.9 mg/dL), BUN 58 mg/dL, K 5.4 mEq/L. No presenta edemas y su examen físico es normal. ¿Cuál es la explicación farmacológica de este cuadro?**

A) Toxicidad tubular directa de la metformina sobre las células del túbulo distal
B) El ibuprofeno inhibe la vasodilatación de la arteriola aferente y el losartán impide la vasoconstricción de la arteriola eferente
C) El losartán produce vasoconstricción de la arteriola aferente y el ibuprofeno vasodilatación eferente
D) Inducción de nefritis lúpica proliferativa difusa por fármacos antihipertensivos
E) Precipitación intraluminal de cristales de metformina en el asa de Henle

PREGUNTA 10 1.09.1.013

**10.** **Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm3, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. Identificar el posible diagnóstico:**

A) Glomerulonefritis post estreptocócica
B) Vasculitis de vasos pequeños
C) Injuria renal pre renal
D) Endocarditis infecciosa
E) Nefritis intersticial

PREGUNTA 11 1.09.2.004

**11.** **Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. ¿Qué examen debe pedirse a continuación?**

A) Creatininkinasa
B) Proteinuria de 24 horas
C) Hemograma
D) Sedimento de orina
E) Clearence de creatinina

PREGUNTA 12 1.09.2.004, 1.09.1.013

**12.** **Hombre de 28 años ingresa tras colapso durante una maratón en día caluroso. Al ingreso está obnubilado, deshidratado, con mialgias generalizadas severas. Exámenes: Creatinina 4.2 mg/dL, K 6.1 mEq/L, CPK 68.000 U/L. La orina es de color marrón oscuro; la tira reactiva marca 4+ de sangre, pero el sedimento microscópico muestra apenas 0-2 hematíes por campo. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para prevenir mayor daño renal?**

A) Hemodiálisis de urgencia con filtro de alta permeabilidad
B) Hidratación intravenosa agresiva con cristaloides isotónicos
C) Iniciar corticoides en altas dosis por sospecha de miositis autoinmune
D) Administrar furosemida en infusión continua sin aporte de volumen
E) Indicar tratamiento con manitol al 20% en bolo cada 4 horas

PREGUNTA 13 1.09.2.004, 1.09.1.013

**13.** **Mujer de 70 años con antecedente de artrosis y dispepsia en tratamiento con Omeprazol y Naproxeno. Consulta por astenia y náuseas. Laboratorio muestra elevación de creatinina sérica a 3.2 mg/dL (basal de hace 2 meses: 0.9 mg/dL). El sedimento urinario muestra 25 leucocitos por campo, cilindros leucocitarios y eosinófilos en orina (tinción de Hansel positiva). El urocultivo es negativo. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Iniciar ciprofloxacino por sospecha de pielonefritis aguda
B) Suspender de inmediato omeprazol y naproxeno
C) Realizar pielografía ascendente retrógrada
D) Indicar diálisis peritoneal continua
E) Aumentar la dosis de IBP para proteger la mucosa gástrica

PREGUNTA 14 1.09.1.023

**14.** **Hombre de 56 años con diabetes mellitus y nefropatía diabética avanzada consulta en el servicio de urgencias por disnea de reposo y ortopnea progresiva. Al examen: PA 180/100 mmHg, FC 105 lpm, SatO2 86% ambiental. Se auscultan crepitaciones bilaterales difusas hasta los tercios superiores de ambos campos pulmonares. Se administran 120 mg de furosemida IV sin lograr diuresis a los 45 minutos. Gases arteriales: pH 7.22, PaO2 55 mmHg, PaCO2 32 mmHg, HCO3 12 mEq/L. Creatinina 6.4 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir bolo de 240 mg de furosemida IV
B) Instalar catéter y realizar hemodiálisis de urgencia
C) Administrar bicarbonato de sodio al 8.4% en infusión continua
D) Iniciar infusión de nitroglicerina y nebulizaciones con salbutamol
E) Indicar ventilación mecánica no invasiva con CPAP y esperar 24 horas

PREGUNTA 15 1.09.1.023, 1.09.3.004, 1.09.5.003

**15.** **Hombre de 56 años con diabetes mellitus y nefropatía diabética avanzada consulta en el servicio de urgencias por disnea de reposo y ortopnea progresiva. Al examen: PA 180/100 mmHg, FC 105 lpm, SatO2 86% ambiental. Se auscultan crepitaciones bilaterales difusas hasta los tercios superiores de ambos campos pulmonares. Se administran 120 mg de furosemida IV sin lograr diuresis a los 45 minutos. Gases arteriales: pH 7.22, PaO2 55 mmHg, PaCO2 32 mmHg, HCO3 12 mEq/L. Creatinina 6.4 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir bolo de 240 mg de furosemida IV
B) Instalar catéter y realizar hemodiálisis de urgencia
C) Administrar bicarbonato de sodio al 8.4% en infusión continua
D) Iniciar infusión de nitroglicerina y nebulizaciones con salbutamol
E) Indicar ventilación mecánica no invasiva con CPAP y esperar 24 horas

PREGUNTA 16 1.09.1.023, 1.09.3.004, 1.09.5.003

**16.** **Mujer de 42 años con antecedente de trastorno bipolar en tratamiento crónico con Carbonato de Litio es traída a urgencias por cuadro de compromiso de conciencia, temblor grosero, ataxia y disartria tras deshidratación por diarrea. Los exámenes muestran Creatinina 3.8 mg/dL y una Litemia de 4.8 mEq/L (rango terapéutico 0.6-1.2 mEq/L). ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección?**

A) Lavado gástrico con carbón activado seriado
B) Hemodiálisis de urgencia
C) Administración de poliestireno sulfonato de sodio oral
D) Alcalinización urinaria con bicarbonato de sodio
E) Forzar diuresis osmótica con manitol

PREGUNTA 17 1.09.1.020

**17.** **Un paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, sin tratamiento, consulta por edema de las extremidades inferiores y malestar. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 70x', edema marcado en ambas extremidades inferiores, con signo de la fóvea, hígado palpable, examen cardíaco normal y murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos basales. En sus exámenes destaca creatinina: 2,2 mg/dl, 5 mg/dl, Na+: 136 mEq/l, K+: 5,3 mEq/l y Cl-: 95 mEq/l. ¿Qué diurético es de elección para el manejo del edema en este paciente?**

A) Clortalidona
B) Hidroclorotiazida
C) Furosemida
D) Indapamida
E) Espironolactona

PREGUNTA 18 1.09.2.003

**18. Hombre de 52 años con cirrosis hepática Child-Pugh C por virus de hepatitis C y ascitis refractaria, hospitalizado por hemorragia digestiva alta variceal resuelta con ligadura endoscópica. A las 72 horas presenta oliguria con elevación de creatinina sérica desde 0.8 mg/dL a 2.6 mg/dL. Se suspenden diuréticos y se infunde albúmina humana al 20% a dosis de 1 g/kg/día durante 48 horas consecutivas, manteniéndose la creatinina en 2.5 mg/dL. Sedimento urinario: 2-3 leucocitos por campo, sin cilindros ni proteinuria. Sodio urinario: 6 mEq/L. Presión arterial: 100/60 mmHg. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Hemodiálisis trisemanal ambulatoria
B) Terlipresina intravenosa asociada a albúmina
C) Infusión de dopamina a dosis renales vasodilatadoras (2 mcg/kg/min)
D) Bolo de furosemida de 120 mg IV
E) Paracentesis evacuadora total de 8 litros sin reposición

## BLOQUE 2 TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)

PREGUNTA 19 1.09.2.007

**19. Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes/año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un cuadro de 7 días de evolución de cefalea y tendencia a la desorientación. En sus exámenes destaca una concentración sérica de sodio de 121 mEq/L, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) SIADH (Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome carcinoide
D) Accidente vascular encefálico
E) Hipercalcemia

PREGUNTA 20 1.09.2.007

**20. Hombre 60 años con inicio hace 3 semanas de carbamazepina, comienza con náuseas, malestar gástrico, confusión hace 2 días, alteración electrolítica:**

A) Hiponatremia
B) HIPOCALCEMIA???. Era hiponatremia inducida por carbamazepina. - además la clínica (compromiso SNC) orientaba a disnatremia, no tenía nada de discalcemia/diskalemia.
C) Hipokalemia
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

PREGUNTA 21 1.09.2.007

**21. En el enfrentamiento clínico sistemático de Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando 1.6 a 2.0 mEq/L de Na por cada 100 mg/dL de glicemia sobre 100 mg/dL.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 22 1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016

**22. Hombre de 60 años con diagnóstico reciente de neuralgia del trigémino en tratamiento con Carbamazepina desde hace 3 semanas. Consulta por astenia, mareos, náuseas y confusión progresiva de 48 horas de evolución. Al examen físico: orientado en persona pero desorientado en tiempo y espacio, PA 125/75 mmHg, FC 74 lpm, hidratado, sin edemas periféricos ni focalidad neurológica. Exámenes de laboratorio: Glicemia 92 mg/dL, Sodio sérico 118 mEq/L, Potasio 4.2 mEq/L, Creatinina 0.7 mg/dL, Sodio urinario 52 mEq/L, Osmolaridad urinaria 380 mOsm/kg. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico y el diagnóstico etiológico más probable?**

A) Hiponatremia euvolémica secundaria a SIADH inducido por carbamazepina
B) Hiponatremia hipovolémica por pérdida renal de sal
C) Pseudohiponatremia por hipertrigliceridemia farmacológica
D) Diabetes insípida central neurogénica
E) Insuficiencia suprarrenal primaria inducida por fármacos

PREGUNTA 23 1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016

**23. Mujer de 70 años con antecedente de depresión en tratamiento con sertralina ingresa a urgencias en coma no reactivo tras presentar dos convulsiones tónico-clónicas generalizadas en su domicilio. Laboratorio de urgencia: Glicemia 105 mg/dL, Sodio plasmático 108 mEq/L, Potasio 3.9 mEq/L, Osmolaridad plasmática 225 mOsm/kg. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?**

A) Infusión continua de Suero Fisiológico 0.9% a 250 mL/hora
B) Bolo intravenoso de 100 a 150 mL de Suero Salino Hipertónico al 3% en 20 minutos
C) Restricción hídrica estricta a 500 mL/día y control electrolítico en 24 horas
D) Administración de 40 mg de furosemida intravenosa en bolo
E) Infusión rápida de Suero Glucosado al 5% con ampolla de cloruro de potasio

PREGUNTA 24 1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016

**24. Hombre de 54 años con alcoholismo crónico severo y desnutrición ingresa con sodio sérico de 102 mEq/L por hiponatremia hipotónica. Se inicia reposición hidroelectrolítica con solución salina. A las 20 horas de ingreso, el control de laboratorio muestra sodio plasmático en 120 mEq/L (aumento de 18 mEq/L). El paciente evoluciona con disartria, disfagia, tetraparesia espástica y compromiso progresivo de la vigilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta complicación?**

A) Hematoma subdural crónico reagudizado
B) Encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina
C) Síndrome de desmielinización osmótica (mielinolisis pontina central)
D) Accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media
E) Delirium tremens por deprivación alcohólica aguda

PREGUNTA 25 1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016

**25. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los diuréticos tiazídicos (ej. hidroclorotiazida, clortalidona) producen hiponatremia con mayor frecuencia y severidad que los diuréticos de asa (ej. furosemida)?**

A) Las tiazidas actúan en el túbulo contorneado distal bloqueando la excreción de agua libre sin interferir con la médula hiperosmolar
B) Las tiazidas destruyen directamente el gradiente medular de concentración en el asa de Henle
C) Las tiazidas inhiben la síntesis central de hormona antidiurética a nivel supraóptico
D) La furosemida produce mayor pérdida de sodio urinario que las tiazidas por miligramo de fármaco
E) Las tiazidas estimulan de manera directa a los osmorreceptores hipotalámicos induciendo sed patológica

PREGUNTA 26 1.09.1.010

**26. Una paciente de 60 años, con antecedente de hipotiroidismo, hipertensión y depresión, en tratamiento con levotiroxina, enalapril y citalopram se realiza exámenes de control, entre los que destacan sodio plasmático de 127 mEq/L, potasio plasmático de 4,1 mEq/L, creatinina plasmática de 0,9 mg/dl y sodio urinario de 60 mEq/L. ¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?**

A) Uso del enalapril
B) Reacción secundaria al citalopram
C) Síndrome paraneoplásico
D) Insuficiencia suprarrenal
E) Hipotiroidismo descompensado

PREGUNTA 27 1.09.1.010

**27. Paciente mujer joven sodio bajo osmolaridad sanguínea baja, sodio urinario sobre 100, osmolaridad urinaria 520 (VN 50-1200), VEC normal a. SIADH b. Uso de diuréticos (creo que era esta, pues el SIADH debería tener osmolaridad urinaria alta, que alguien confirme pls)**

C) Insuficiencia suprarrenal
D) Hipotiroidismo
C) Ninguna de las anteriores es correcta
D) Todas las anteriores son correctas
E) No se dispone de información suficiente

PREGUNTA 28 1.09.1.010

**28. En el enfrentamiento clínico sistemático de SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu > 100 mOsm/kg) y Nau > 40 mEq/L.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 29 1.09.1.010, 1.09.2.007

**29. Mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial y depresión mayor tratada con Enalapril y Citalopram consulta para chequeo de rutina. Está completamente asintomática. En sus exámenes destaca: Sodio sérico 127 mEq/L, Potasio 4.1 mEq/L, Creatinina 0.9 mg/dL, Glicemia 88 mg/dL, Osmolaridad plasmática 262 mOsm/kg, Sodio urinario 60 mEq/L y Osmolaridad urinaria 520 mOsm/kg. Al examen físico no presenta edemas ni ortostatismo, signos vitales normales. Pruebas tiroideas y cortisol matinal normales. ¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?**

A) Efecto adverso del Enalapril por disminución de aldosterona
B) Secreción inadecuada de ADH (SIADH) secundaria a Citalopram
C) Insuficiencia suprarrenal primaria oculta
D) Pérdida renal de sodio por tubulopatía crónica
E) Hipotiroidismo primario descompensado

PREGUNTA 30 1.09.1.010, 1.09.2.007

**30.** **Hombre de 72 años con tabaquismo severo consulta por tos crónica, baja de peso y desorientación fluctuante en la última semana. Al examen físico: adelgazado, vigil, pero desorientado en tiempo, sin focalidad neurológica, PA 130/80 mmHg, hidratado y sin edema. Exámenes: Sodio sérico 121 mEq/L, Sodio urinario 65 mEq/L, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg. La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha de bordes espiculados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del trastorno electrolítico?**

A) SIADH por secreción ectópica paraneoplásica de carcinoma pulmonar de células pequeñas
B) Metástasis suprarrenales bilaterales con enfermedad de Addison
C) Síndrome hiperosmolar secundario a neoplasia pulmonar
D) Hiponatremia hipervolémica por insuficiencia cardíaca congestiva
E) Pseudohiponatremia por hiperproteinemia paraneoplásica

PREGUNTA 31 1.09.1.007

**31.** **Paciente usuaria de lamotrigina, ácido valproico y litio, presenta diuresis de 12.600 mL/día, deshidratación e hipernatremia. ¿Cuál es la causa más probable?**

A) Ácido valproico
B) Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica)
C) Lamotrigina
D) Polidipsia psicogénica inducida por antipsicóticos
E) Hiperglicemia osmótica

PREGUNTA 32 1.09.1.007

**32.** **Un paciente de 25 años, con antecedente de trastorno bipolar de difícil manejo, en tratamiento con lamotrigina, litio, diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de poliuria de cerca de 12 litros diarios, asociado a alta ingesta de aguda. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, sodio: 154 mEq/L, potasio: 4,5 mEq/L, glicemia de ayunas: 80 mg/dl y hemograma normal. ¿Cuál de las siguientes opciones explica sus alteraciones?**

A) Polidipsia psicógena
B) Consumo de lamotrigina
C) Consumo de litio
D) Consumo de clorpromazina
E) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

PREGUNTA 33 1.09.1.007, 1.09.2.008

**33.** **Mujer de 28 años con antecedente de trastorno afectivo bipolar en tratamiento regular con carbonato de litio consulta por cuadro de varias semanas de polidipsia intensa y poliuria con volúmenes urinarios cercanos a 12 litros al día. Laboratorio muestra: Sodio plasmático 152 mEq/L, Glicemia 84 mg/dL, Osmolaridad urinaria 110 mOsm/kg. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario causante de su poliuria?**

A) Diuresis osmótica inducida por hiperglicemia y glucosuria
B) Resistencia del túbulo colector renal a la acción de la hormona antidiurética (diabetes insípida nefrogénica)
C) Inhibición de la secreción de vasopresina a nivel hipotalámico por el litio
D) Polidipsia primaria con supresión fisiológica total de la ADH
E) Destrucción necrótica de los túbulos proximales por toxicidad farmacológica

PREGUNTA 34 1.09.1.007, 1.09.2.008

**34.** **Hombre de 22 años sufre traumatismo encéfalo-craneano cerrado con fractura de la base del cráneo en accidente de tránsito. Al tercer día de hospitalización en UCI, presenta bruscamente poliuria de 600 mL/hora durante 4 horas consecutivas. Exámenes: Sodio sérico 150 mEq/L, Osmolaridad urinaria 140 mOsm/kg. Se sospecha diabetes insípida de origen central. ¿Cuál es la prueba diagnóstica y terapéutica inicial de elección para confirmar la sospecha?**

A) Prueba de deshidratación o privación de agua durante 12 horas
B) Administración de una dosis de prueba de Desmopresina (DDAVP) y medición seriada de osmolaridad urinaria
C) Resonancia nuclear magnética de silla turca con gadolinio
D) Medición de niveles séricos de vasopresina basal y post estímulo con suero salino hipertónico
E) Biopsia de glándula hipofisiaria guiada por estereotaxia

PREGUNTA 35 1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009

**35.** **Hombre de 75 años con antecedente de insuficiencia renal crónica con TFG estimada de 24 mL/min (Creatinina 2.4 mg/dL) e insuficiencia cardíaca compensada consulta por aumento progresivo de edema en extremidades inferiores hasta rodillas y ortopnea de 2 almohadas. ¿Cuál es el diurético de elección para lograr la descongestión y balance negativo en este paciente?**

A) Hidroclorotiazida
B) Clortalidona
C) Furosemida
D) Indapamida
E) Espironolactona en monoterapia

PREGUNTA 36 1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009

**36.** **Mujer de 78 años con hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida presenta 4 días de diarrea aguda abundante. Al ingreso: soporosa, PA 75/45 mmHg, FC 120 lpm, llene capilar de 4 segundos. Laboratorio de urgencia: Sodio plasmático 156 mEq/L, Potasio 3.2 mEq/L, Creatinina 2.8 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes fluidos intravenosos debe administrarse en primer lugar?**

A) Suero Glucosado al 5% a 500 mL/hora
B) Suero Fisiológico al 0.9% en bolo inicial
C) Solución salina al 3%
D) Agua destilada por vía venosa periférica
E) Solución de bicarbonato 2/3 molar

PREGUNTA 37 1.09.2.005

**37. Paciente con bradicardia de 30 lpm e hiperkalemia de 8,3 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Bicarbonato de sodio endovenoso
B) Insulina + glucosa endovenosa
C) Gluconato de calcio endovenoso
D) Kayexalate oral
E) Hemodiálisis de urgencia

PREGUNTA 38 1.09.2.005, 1.09.4.016

**38. Hombre de 68 años con antecedentes de cardiopatía hipertensiva y enfermedad renal crónica estadio 4 consulta por marcada debilidad muscular y palpitaciones lentas. Al examen físico: PA 80/50 mmHg, FC 32 lpm. El monitor muestra ritmo de la unión con QRS ensanchado a 160 ms y ondas T picudas simétricas de gran amplitud. El laboratorio de urgencia informa Potasio plasmático en 8.4 mEq/L. ¿Cuál es la intervención terapéutica inicial prioritaria que debe administrarse de inmediato?**

A) Bicarbonato de sodio 2/3 molar en infusión rápida
B) Insulina cristalina 10 UI asociada a 100 mL de suero glucosado al 30%
C) Gluconato de calcio al 10% intravenoso en 2 a 5 minutos
D) Instalación de marcapasos transitorio transvenoso de urgencia
E) Hemodiálisis inmediata por catéter venoso central

PREGUNTA 39 1.09.2.005, 1.09.4.016

**39. Mujer de 72 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial tratada con Enalapril 20 mg cada 12 horas y Espironolactona 25 mg/día consulta por astenia y malestar general. El ECG revela prolongación del intervalo PR y ondas T altas y acuminadas. El potasio sérico es de 7.2 mEq/L. Se administra una ampolla de gluconato de calcio al 10% IV, revirtiendo transitoriamente los cambios en el ECG. ¿Cuál es el paso siguiente para inducir un rápido desplazamiento del potasio hacia el espacio intracelular?**

A) Resina de intercambio catiónico (sulfonato de poliestireno sódico) por sonda nasogástrica
B) Bolo intravenoso de 10 UI de insulina rápida junto con solución glucosada hipertónica
C) Infusión continua de cloruro de potasio a bajas dosis
D) Bolo de furosemida 120 mg intravenoso
E) Suspender el enalapril y citar a control ambulatorio en 48 horas

PREGUNTA 40 1.09.2.005, 1.09.4.016

**40. Hombre de 27 años con antecedente de insuficiencia renal crónica terminal en programa de hemodiálisis trisemanal no acude a su sesión programada del sábado. El lunes por la mañana consulta en urgencias con marcada debilidad muscular y dificultad para movilizar las extremidades inferiores. Al examen físico se constata tetraparesia flácida simétrica con reflejos osteotendinosos abolidos y frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?**

A) Síndrome de Guillain-Barré
B) Hipokalemia por pérdidas digestivas ocultas
C) Hiperkalemia grave por omisión de terapia de reemplazo renal
D) Accidente cerebrovascular isquémico de tronco encefálico
E) Crisis miasténica autoinmune

PREGUNTA 41 1.09.2.005, 1.09.4.016

**41. Un médico evalúa a un paciente asintomático de 45 años cuyos exámenes de rutina en sangre venosa periférica informan un potasio plasmático de 6.8 mEq/L. El paciente no presenta antecedentes mórbidos, el examen físico es normal y el electrocardiograma de 12 derivaciones es estrictamente normal sin ondas T picudas ni ensanchamiento de complejos. El hemograma muestra plaquetas de 750.000/uL y glóbulos blancos normales. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Indicar hemodiálisis de urgencia inmediata
B) Administrar 10 mL de gluconato de calcio al 10% IV
C) Sospechar pseudohiperkalemia y repetir la toma de muestra venosa sin torniquete
D) Administrar sulfonato de poliestireno sódico oral cada 6 horas
E) Iniciar infusión continua de bicarbonato de sodio isotónico

PREGUNTA 42 1.09.2.006

**42. Un paciente de 56 años, hipertenso, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida presenta irregularidad en sus presiones arteriales, por lo que se decide reemplazar el diurético por clortalidona, con buena respuesta. Se solicitan exámenes de control, entre los que destacan creatinina: 1,0 mg/dl, potasemia: 3,3 mEq/L y natremia: 140 mEq/L. La conducta más adecuada es:**

A) Reemplazar el enalapril por losartán
B) Disminuir cloruro de sodio
C) Reemplazar la clortalidona por furosemida
D) Administrar suero fisiológico
E) Disminuir la dosis de enalapril

PREGUNTA 43 1.09.2.006, 1.09.3.009

**43. Hombre de 62 años con antecedente de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular crónica en tratamiento con digoxina y furosemida consulta por náuseas, astenia y mareos. El ECG muestra bradiarritmia con extrasístoles ventriculares frecuentes, aplanamiento de ondas T y ondas U notorias. El potasio plasmático es de 2.6 mEq/L. ¿Cuál es el riesgo farmacológico inmediato más grave de esta alteración electrolítica?**

A) Precipitación de intoxicación digitálica severa con arritmias ventriculares letales
B) Desarrollo de insuficiencia renal aguda prerrenal anúrica
C) Parálisis periódica tirotóxica irreversible
D) Bloqueo auriculoventricular de primer grado benigno autolimitado
E) Aparición de hipocalcemia sintomática aguda

PREGUNTA 44 1.09.2.006, 1.09.3.009

**44.** **Una paciente de 48 años hospitalizada por pancreatitis aguda en resolución presenta debilidad muscular y calambres. Sus exámenes revelan potasio de 2.9 mEq/L. Se prescribe reposición con cloruro de potasio intravenoso por vía venosa periférica. ¿Cuáles son la concentración máxima recomendada en la solución y la velocidad de infusión periférica segura para prevenir flebitis y toxicidad cardíaca?**

A) Concentración máxima de 40 mEq/L y velocidad no superior a 10 a 20 mEq/hora
B) Concentración máxima de 100 mEq/L y velocidad no superior a 40 mEq/hora
C) Concentración máxima de 20 mEq/L y velocidad obligada de 5 mEq/día
D) Concentración máxima de 80 mEq/L administrada en bolo rápido de 5 minutos
E) Concentración de 60 mEq/L exclusivamente diluida en suero glucosado al 10%

PREGUNTA 45 1.09.1.001

**45.** **Un paciente de 66 años con antecedente de insuficiencia renal crónica, en etapa IIIB, con creatinina estable en 1,8 mg/dl y clearence de creatinina estimado de 35 ml/min. Se realiza exámenes de laboratorio que muestran sodio: 138 mEq/L, cloro: 102 mEq/L potasio: 4,8 mEq/L, bicarbonato plasmático: 16 mEq/L y anion gap: 10. ¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?**

A) Acumulación de ácidos orgánicos
B) Disminución de la producción de bicarbonato
C) Cetosis
D) Acumulación de ácido úrico
E) Intoxicación por medicamentos

PREGUNTA 46 1.09.1.001

**46.** **Un paciente de 82 años, diabético e hipertenso, consulta por malestar general y edema de extremidades inferiores. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 63x', edema blando bimaleolar +++. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 86 mg/dl, K+: 5,8 mEq/L, Na+: 133 mEq/L, bicarbonato: 15 mmol/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Hemodiálisis
B) Gluconato de calcio
C) Peritoneodiálisis
D) Bicarbonato de sodio
E) Amlodipino

PREGUNTA 47 1.09.1.001, 1.09.4.016

**47.** **Hombre de 66 años con antecedentes de enfermedad renal crónica estadio G3b (filtrado glomerular estimado de 35 mL/min, creatinina basal 1.8 mg/dL) se realiza exámenes de control ambulatorio en policlínico. El perfil bioquímico muestra: Sodio 138 mEq/L, Cloro 104 mEq/L, Potasio 4.8 mEq/L, Bicarbonato sérico 16 mEq/L. El Anion Gap calculado es de 10 mEq/L (rango normal 8–12). ¿Cuál es la causa fisiopatológica más probable de este trastorno ácido-base?**

A) Acumulación desproporcionada de aniones orgánicos no medidos
B) Disminución de la síntesis renal de amonio y retención compensatoria de cloro (anion gap normal)
C) Cetoacidosis por resistencia periférica a la insulina
D) Depósito tisular de ácido úrico por hiperuricemia secundaria
E) Intoxicación medicamentosa inadvertida por AINEs

PREGUNTA 48 1.09.1.001, 1.09.4.016

**48.** **Mujer de 19 años es traída a la urgencia tras ingerir una sustancia desconocida en intento de autolisis. Se encuentra con compromiso de conciencia, taquipneica y con visión borrosa refiere ver "como en una tormenta de nieve". Exámenes: Gases arteriales muestran pH 7.10, HCO3 7 mEq/L, pCO2 18 mmHg. Sodio 140 mEq/L, Cloro 96 mEq/L, Glicemia 90 mg/dL, BUN 14 mg/dL. Osmolaridad plasmática medida por laboratorio: 330 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico toxicológico más probable?**

A) Intoxicación por monóxido de carbono
B) Intoxicación por metanol
C) Intoxicación por paracetamol
D) Sobredosis de benzodiacepinas
E) Intoxicación por insecticidas organofosforados

PREGUNTA 49 1.09.1.001, 1.09.4.016

**49.** **Hombre de 58 años en shock séptico de foco pulmonar ingresa a UCI conectado a ventilación mecánica. Los gases arteriales de control muestran: pH 7.22, HCO3 10 mEq/L. Según la fórmula de Winter, ¿cuál es el valor de pCO2 esperado para considerar que la compensación ventilatoria es apropiada y que no existe un trastorno respiratorio sobreagregado?**

A) 12 a 16 mmHg
B) 21 a 25 mmHg
C) 35 a 45 mmHg
D) 28 a 32 mmHg
E) 40 a 48 mmHg

PREGUNTA 50 1.09.1.001, 1.09.4.016

**50.** **¿Cuál de las siguientes es una indicación precisa y justificada para la administración de bicarbonato de sodio intravenoso en un paciente con acidosis metabólica aguda?**

A) Cetoacidosis diabética con pH de 7.25 y bicarbonato de 14 mEq/L
B) Acidosis metabólica severa con pH menor a 7.10 e inestabilidad hemodinámica
C) Acidosis láctica por shock séptico con pH de 7.20 en paciente normotenso
D) Para corregir de forma rápida el anion gap en insuficiencia renal leve
E) En todo paro cardiorrespiratorio al inicio de las maniobras de RCP

PREGUNTA 51 1.09.1.002

**51. [ATENCIÓN PRIMARIA: Acidosis metabólica · 1.09.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Acidosis metabólica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 52 1.09.1.003

**52. [ATENCIÓN PRIMARIA: Alcalosis metabólica · 1.09.1.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Alcalosis metabólica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 53 1.09.2.008, 1.09.4.016

**53. Mujer de 42 años ingresa a urgencias con debilidad muscular severa, espasmos carpopedales involuntarios y parestesias periorales tras una semana de vómitos reiterados por gastroparesia. Gases arteriales muestran pH 7.56, HCO3 40 mEq/L, pCO2 46 mmHg. Sodio 136 mEq/L, Cloro 80 mEq/L, Potasio 2.7 mEq/L. Cloro urinario resulta en 6 mEq/L. ¿Cuál es el tratamiento de elección para corregir el trastorno ácido-base?**

A) Infusión de ácido clorhídrico 0.1 N por vía venosa central
B) Administración de Suero Fisiológico al 0.9% con Cloruro de Potasio intravenoso
C) Acetazolamida intravenosa en bolo
D) Infusión continua de Suero Glucosado al 5% con bicarbonato
E) Espironolactona oral a dosis altas

PREGUNTA 54 1.09.2.008, 1.09.4.016

**54. Hombre de 48 años con hipertensión arterial de difícil control refractaria a 3 fármacos en dosis plenas consulta por astenia y calambres. En sus exámenes destaca: PA 175/105 mmHg, Sodio 144 mEq/L, Potasio 2.9 mEq/L, Bicarbonato 34 mEq/L, pH 7.48. El cloro urinario es de 48 mEq/L. No toma diuréticos ni presenta edemas. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable?**

A) Hiperaldosteronismo primario (adenoma suprarrenal productor de aldosterona)
B) Vómitos psicógenos subrepticios con deshidratación
C) Síndrome de Bartter del adulto
D) Insuficiencia suprarrenal primaria
E) Nefropatía pierde sal con hipovolemia

## BLOQUE 4 SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS

PREGUNTA 55 1.09.1.018

**55. Paciente de 25 años, deportista, corre una triatlón, luego de esta competencia, para evaluación de dopaje se realiza examen de orina, el cual muestra proteinuria ++, sin presencia de drogas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su proteinuria?**

A) Proteinuria funcional
B) Rabdomiolisis
C) Deshidratación
D) Acidosis metabólica
E) Glomerulopatía membranosa

PREGUNTA 56 1.09.1.022

**56. Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas. Proteinuria 24h: 8 g. Albúmina 2.0 g/dL. Sin hematuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome nefrótico puro
B) Síndrome nefrítico agudo
C) Glomerulonefritis membranoproliferativa
D) Nefropatía IgA
E) Pielonefritis crónica

PREGUNTA 57 1.09.1.022, 1.09.4.016

**57.** **Hombre de 65 años con síndrome nefrótico en estudio con proteinuria de 24 horas de 6.5 gramos y albúmina sérica de 2.0 g/dL presenta dolor torácico súbito de tipo pleurítico, disnea y taquipnea. Al examen físico: saturación de oxígeno 88% aire ambiental, FC 115 lpm, PA 110/70 mmHg. La auscultación pulmonar no revela estertores patológicos significativos. ¿Cuál es la complicación aguda más probable de su cuadro renal?**

A) Neumonía bacteriana comunitaria por Streptococcus pneumoniae
B) Tromboembolismo pulmonar agudo secundario a pérdida urinaria de antitrombina III
C) Edema agudo de pulmón no cardiogénico por hipoalbuminemia
D) Infarto agudo de miocardio transmural
E) Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco

PREGUNTA 58 1.09.1.022, 1.09.4.016

**58.** **Mujer de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de un mes de evolución de edema bimaleolar progresivo y edema palpebral matinal. Exámenes de laboratorio: Creatinina 0.8 mg/dL, Albúmina sérica 2.4 g/dL, Colesterol total 380 mg/dL. Sedimento de orina: sin hematuria ni leucocituria, presencia de abundantes cuerpos ovales grasos. Proteinuria cuantitativa de 24 horas: 7.2 gramos. Anticuerpos antinucleares (ANA) negativos, C3 y C4 normales. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección para proseguir el estudio de esta paciente?**

A) Iniciar prednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día de forma empírica
B) Realizar biopsia renal percutánea
C) Solicitar electroforesis e inmunofijación de proteínas en suero y orina
D) Indicar tratamiento antiproteinúrico exclusivo con losartán y citar a control en 6 meses
E) Ecografía Doppler de arterias y venas renales como único estudio

PREGUNTA 59 1.09.1.022, 1.09.4.016

**59.** **Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas. Al examen físico se constata edema con fóvea en ambas extremidades inferiores hasta rodillas. Exámenes: Proteinuria de 24 horas: 8.0 gramos. Albúmina plasmática: 2.0 g/dL. Sedimento urinario sin hematíes ni cilindros hemáticos. ¿Cuál es el diagnóstico sindromático más probable?**

A) Síndrome nefrótico puro
B) Síndrome nefrítico agudo
C) Glomerulonefritis membranoproliferativa
D) Nefropatía por depósitos de IgA
E) Pielonefritis crónica con proteinuria tubular

PREGUNTA 60 1.09.1.022, 1.09.4.016

**60.** **¿Cuál de los siguientes hallazgos en el sedimento microscópico de orina analizado bajo luz polarizada es patognomónico de síndrome nefrótico y lipiduria?**

A) Cilindros céreos anchos de bordes mellados
B) Gotas lipídicas y cuerpos ovales grasos con birrefringencia en Cruz de Malta
C) Cilindros hemáticos con hematíes espiculados
D) Cristales de oxalato de calcio en sobre de carta
E) Cilindros leucocitarios con piuria estéril

PREGUNTA 61 1.09.2.001

**61.** **[URGENCIA: Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones: · 1.09.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones:. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 62 1.09.1.022

**62.** **Hombre de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2 a 4 hematíes por campo, 5 leucocitos por campo, creatininemia de 1.1 mg/dL y proteinuria cuantitativa de 24 horas de 7.0 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nefropatía por depósitos de IgA (enfermedad de Berger)
B) Glomerulonefritis lúpica clase IV
C) Glomerulonefritis postestreptocócica
D) Glomerulonefritis rápidamente progresiva pauciinmune
E) Nefropatía membranosa

PREGUNTA 63 1.09.1.022

**63.** **Hombre de 58 años es diagnosticado mediante biopsia renal de nefropatía membranosa idiopática. Sus niveles séricos de anticuerpos anti-PLA2R resultan negativos. ¿Cuál es la conducta diagnóstica complementaria prioritaria que se debe realizar en este paciente?**

A) Cribado exhaustivo de neoplasia sólida oculta (colon, pulmón, próstata) y serologías virales (VHB)
B) Mielograma para descartar leucemia mieloide aguda
C) Punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo
D) Ecocardiograma transesofágico en busca de vegetaciones
E) Iniciar hemodiálisis de mantención de inmediato

PREGUNTA 64 1.09.1.021

**64.** **Una paciente de 21 años, consulta por cuadro de algunos días de evolución de aste- nia, compromiso del estado general y disnea progresiva que actualmente es de mínimos esfuerzos, además ha presentado hematuria. Al examen físico su frecuencia cardiaca es 75 por minuto, con presión arterial 180/110 mmHg. Se aprecia edema facial y de extre- midades inferiores, con signo de la fóvea. Su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en tres tiempos con presencia de R3 y se auscultan crépitos pulmonares bilate- rales, mayores en ambas bases. Se solicitan exámenes que muestran hematuria dismór-**

A) Prednisona vía oral
B) Furosemida endovenosa
C) Bisoprolol vía oral
D) Captopril vía oral
E) Amoxicilina vía oral

PREGUNTA 65 1.09.1.021

**65.** **Hombre de 21 años consulta por disnea de medianos esfuerzos, cefalea y emisión de orinas color café oscuro de 2 días de evolución. Hace dos semanas cursó amigdalitis pultácea. Al examen físico: PA 180/110 mmHg, FC 75 lpm, edema periorbitario bilateral y crepitaciones inspiratorias bibasales. Sedimento de orina: hematuria dismórfica masiva (90%), acantocitos y cilindros hemáticos, proteinuria de 900 mg/24 horas. C3 plasmático disminuido y C4 normal. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial prioritaria?**

A) Iniciar prednisona oral a dosis inmunosupresoras
B) Administrar furosemida intravenosa y restricción estricta de sodio
C) Pulsos de ciclofosfamida intravenosa
D) Amoxicilina oral por 14 días como tratamiento del daño glomerular
E) Biopsia renal percutánea urgente antes de cualquier medida

PREGUNTA 66 1.09.1.021

**66.** **Hombre de 24 años consulta por orinas rojizas de inicio el día de hoy, que coinciden con el segundo día de un cuadro catarral agudo con odinofagia, coriza y febrícula. Al examen físico: PA 120/70 mmHg, afebril, sin edemas periféricos. El sedimento urinario muestra hematuria con 80% de eritrocitos dismórficos. Los niveles séricos de C3 y C4 son estrictamente normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
B) Nefropatía por depósitos de IgA (enfermedad de Berger)
C) Glomerulonefritis lúpica proliferativa difusa
D) Glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I
E) Nefritis tubulointersticial inmunoalérgica

PREGUNTA 67 1.09.2.013

**67.** **Un paciente de 71 años presenta desde hace dos meses malestar general, mialgias y febrícula ocasional, además de episodios de hematuria, especialmente en el úl8mo 8empo. Al examen Fsico, presenta frecuencia cardíaca 82 la8dos por minuto, presión arterial 176/111 mmHg, edema bimaleolar y disminución del volumen de orina. El examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos 8empos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales, sin otros ruidos. En los exámenes de laboratorio destacan crea8ninemia: 4,34 mg/dL, BUN: 72 mg/dL, sedimento de orina: 10 leucocitos por campo y 60 hema`es por campo, con 10% de acantocitos. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnós8co?**

A) An2cuerpos an2nucleares (ANA)
B) Biopsia renal
C) An2cuerpos an2citoplasma de neutrófilos (ANCA)
D) UroTAC
E) Electroforesis de proteínas en orina

PREGUNTA 68 1.09.2.013, 1.09.4.016

**68.** **Hombre de 71 años presenta malestar general, astenia, mialgias y febrícula desde hace un mes, agregándose hematuria macroscópica y oliguria en los últimos días. Al examen físico: PA 175/110 mmHg, edema bimaleolar. Exámenes muestran creatinina de 4.3 mg/dL (hace 2 meses 1.0 mg/dL), BUN 72 mg/dL y sedimento de orina con abundantes hematíes con 80% de acantocitos y cilindros hemáticos. ¿Qué examen es el más adecuado y concluyente para confirmar el diagnóstico etiológico específico?**

A) Anticuerpos antinucleares (ANA)
B) Biopsia renal percutánea
C) Urotomografía computarizada con contraste
D) Electroforesis de proteínas en orina de 24 horas
E) Cistoscopía diagnóstica con lavado vesical

PREGUNTA 69 1.09.2.013, 1.09.4.016

**69.** **Mujer de 67 años consulta por astenia progresiva, febrícula y edema de miembros inferiores. Al examen: PA 180/110 mmHg, edema con fóvea ++. Exámenes: Creatinina 4.1 mg/dL, BUN 60 mg/dL, sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo con 80% de dismorfia y cilindros hemáticos. Hemograma muestra hemoglobina 11.8 g/dL, leucocitos normales. El panel serológico informa títulos elevados de ANCA positivos y complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
B) Nefropatía diabética avanzada
C) Nefrosis lipoidea a cambios mínimos
D) Vasculitis de vaso pequeño asociada a ANCA
E) Púrpura trombocitopénico trombótico

PREGUNTA 70 1.09.2.013, 1.09.4.016

**70.** **Hombre de 30 años ingresa a la urgencia con tos productiva con hemoptisis franca, disnea y orinas color café oscuro de una semana de evolución. La radiografía de tórax revela infiltrados alveolares bilaterales difusos en alas de mariposa. Gases arteriales con hipoxemia moderada. Laboratorio: Creatinina 5.2 mg/dL, sedimento con cilindros hemáticos. La inmunofluorescencia de la biopsia renal demuestra depósito lineal continuo de IgG a lo largo de la membrana basal glomerular. ¿Cuál es el tratamiento prioritario combinado de rescate?**

A) Pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida + plasmaféresis
B) Antibioticoterapia con ceftriaxona y claritromicina en monoterapia
C) Prednisona oral a dosis bajas y salbutamol inhalado
D) Anticoagulación plena con heparina no fraccionada
E) Hemodiálisis exclusiva sin inmunosupresión

PREGUNTA 71 1.09.2.013, 1.09.4.016

**71.** **¿Cuál es el factor pronóstico anatomopatológico más crítico para determinar la recuperabilidad de la función renal en un paciente con Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva?**

A) El porcentaje de glomérulos con semilunas fibrosas y atrofia tubular irreversible
B) La presencia de glucosuria en orina completa
C) El valor absoluto del ácido úrico plasmático
D) El grado de proteinuria selectiva en 24 horas
E) El tamaño de los riñones en la radiografía simple de abdomen

PREGUNTA 72 1.09.1.006

**72.** **Una paciente de 26 años, consulta por malestar general, asociada a cefalea y orinas oscuras. Refiere fotosensibilidad. Al examen físico tiene FC: 66x'. PA: 160/106 mmHg, úlceras orales y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con eritrocitos abundantes, con 17% de dismorfia, proteinuria 500 mg/L. Su creatinina plasmática resulta 1,4 mg/dl y la fracción del complemento C3 está disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nefropatía lúpica
B) Nefropatía por IgA
C) Vasculitis ANCA positivo
D) Glomerulonefritis postestreptocócica
E) Glomerulopatía por cambios mínimos

## BLOQUE 5 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

PREGUNTA 73 1.09.1.005

**73.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Bacteriuria asintomática · 1.09.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Bacteriuria asintomática. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.09.1.017

**74.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Progresión de la IRC · 1.09.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Progresión de la IRC. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 75 1.09.1.019

**75. [ATENCIÓN PRIMARIA: Riñón poliquístico · 1.09.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Riñón poliquístico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 76 1.09.2.002

**76. [URGENCIA: Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas · 1.09.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 77 1.09.2.012

**77. [URGENCIA: Pre eclampsia · 1.09.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Pre eclampsia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 78 1.09.1.008

**78. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hipertensión arterial esencial · 1.09.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hipertensión arterial esencial. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 79 1.09.1.014

**79. Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático. Al examen físico se encuentra presión arterial de 138/83, sin otros hallazgos. Sus exámenes de control muestran hemoglobina glicosilada en 6.9%, indice proteinuria creatininuria de 0.3, creatinina 0.8 mg/mL. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Aumentar dosis de metformina

B) Iniciar hidroclorotiazida

C) Iniciar enalapril

D) Suspender metformina e indicar insulina

E) Mantener tratamiento actual y reforzar medidas como dieta y ejercicio

PREGUNTA 80 1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016

**80.** **Hombre de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control regular encontrándose asintomático. Al examen físico se pesquisa presión arterial de 138/84 mmHg, sin otros hallazgos patológicos. Sus exámenes de laboratorio revelan: HbA1c 6.9%, Creatinina 0.8 mg/dL, y un Índice Proteinuria/Creatininuria (o RAC) confirmado de 0.3 mg/mg (300 mg/g). ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada e indicada para la protección renal de este paciente?**

A) Aumentar la dosis de metformina a 2.550 mg/día
B) Iniciar hidroclorotiazida 25 mg/día
C) Iniciar enalapril en dosis tituladas
D) Suspender metformina e iniciar esquema de insulina
E) Mantener el tratamiento actual sin modificaciones

PREGUNTA 81 1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016

**81.** **Mujer de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta a control en Cesfam. Trae exámenes que muestran creatinina de 2.1 mg/dL, con una tasa de filtración glomerular estimada de 24 mL/min/1.73m² (confirmada con examen previo de hace 4 meses similar). No presenta síntomas urémicos. De acuerdo a la normativa de Garantías Explícitas en Salud (GES N° 1) en Chile, ¿cuál es la conducta que debe adoptar el médico tratante?**

A) Notificar caso GES N° 1 de ERC Etapa 4 y generar interconsulta prioritaria a Nefrología para ingreso en menos de 30 días
B) Instalar catéter venoso central transitorio para hemodiálisis en el servicio de urgencias
C) Citar a nuevo control en atención primaria en un año para reevaluar función renal
D) Iniciar diálisis peritoneal ambulatoria de forma inmediata en el consultorio
E) Indicar restricción hídrica estricta de 500 mL/día y suspender todo tratamiento oral

PREGUNTA 82 1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016

**82.** **Hombre de 68 años con enfermedad renal crónica estadio 4 en programa de prediálisis es programado para confección de fístula arteriovenosa autóloga. ¿Por qué motivo las guías clínicas recomiendan confeccionar la fístula arteriovenosa con al menos 6 meses de anticipación al inicio previsto de la hemodiálisis?**

A) Para permitir el proceso de maduración y arterialización venosa con adecuado flujo y pared engrosada
B) Para prevenir la aparición de calcificaciones metastásicas en la arteria radial
C) Porque la fístula reduce de inmediato la cifra de creatinina sérica a valores normales
D) Para evitar el uso de eritropoyetina humana recombinante en el paciente
E) Para facilitar la reabsorción distal de potasio en las nefronas residuales

PREGUNTA 83 1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016

**83.** **En un paciente hipertenso con enfermedad renal crónica y proteinuria en quien se inicia tratamiento con Losartán 50 mg/día, se constata a las 2 semanas de control un ascenso de la creatinina sérica desde 1.4 mg/dL hasta 1.65 mg/dL (incremento del 18%) y un potasio sérico de 4.8 mEq/L. El paciente se encuentra clínicamente asintomático y con PA de 128/78 mmHg. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?**

A) Mantener el losartán sin cambios y continuar la monitorización periódica
B) Suspender de inmediato el losartán por toxicidad renal irreversible
C) Reducir la dosis a un cuarto de comprimido y administrar furosemida
D) Indicar hemodiálisis de urgencia por deterioro de filtración
E) Reemplazar el losartán por un AINE a dosis antiinflamatorias

PREGUNTA 84 1.09.1.004

**84.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Anemia en nefrópata · 1.09.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Anemia en nefrópata. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 85 1.09.1.015

**85.** **Un paciente de 64 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica, con clearence de 40 ml/min se realiza exámenes de control que muestran fósforo: 4,0 mg/dl, calcio: 8,5, PTH: 120 pg/ml (VN: menor a 55) y TSH: 4,0 UI/L. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?**

A) Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D
B) Niveles de T4 libre
C) Calciuria de 24 horas
D) Magnesemia
E) Bicarbonato plasmático

PREGUNTA 86 1.09.1.009

**86. Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran intensidad. En su examen físico destaca presión arterial 170/100 mmHg, FC: 72x' y presencia de un soplo abdominal, en el flanco derecho. El diagnóstico más probable es:**

A) Disección aórtica
B) Aneurisma aórtico abdominal
C) Hipertensión esencial
D) Hipertensión renovascular
E) Accidente vascular encefálico

PREGUNTA 87 1.09.1.011

**87. [ATENCIÓN PRIMARIA: Infección urinaria baja (cistitis) · 1.09.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Infección urinaria baja (cistitis). El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 88 1.09.1.016

**88. Mujer con hipoacusia neuro con ITU febril → PNA . Qué ATB dejar: a. Meropenem**

B) Gentamicina
C) Amikacina d. Nitrofurantoína —> aminoglucosidos estarían contraindicados en hipoacusia neurosensorial o no?? si pq son ototoxicos
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

PREGUNTA 89 1.09.2.011

**89. Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por cuadro de fiebre, malestar general, náuseas, disuria dolorosa y dolor lumbar derecho. Al examen físico, tiene fiebre de 38,9°C, frecuencia cardíaca 95x', presenta puño percusión positiva a derecha. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 50 leucocitos por campo y abundantes bacterias, estando pendiente el resultado del urocultivo. Las pruebas de bienestar fetal no muestran alteraciones. ¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para su manejo?**

A) Ciprofloxacino
B) Nitrofurantoína
C) Amoxicilina más ácido clavulánico
D) Ceftriaxona
E) Ampicilina

PREGUNTA 90 1.09.1.012

**90. [ATENCIÓN PRIMARIA: Insuficiencia renal crónica · 1.09.1.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Insuficiencia renal crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A Urolitiasis

1.09.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La hipercalciuria es la alteración más frecuente en Chile (40 a 50% de los pacientes con litiasis). De todos modos esta es una pregunta ridícula e inútil, que no debería hacerse.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A Uropatía obstructiva

1.09.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Uropatía obstructiva" (1.09.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 3 Respuesta: B

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una pregunta muy discutible, pero dado el diagnóstico de deshidratación hipertónica, con marcada hipernatremia e hipecrloremia, da miedo el suero fisiológico (la evidencia no soporta esta recomendación, pero lo habitual es que se crea que el SF puede agravar la hiponatremia). Debería iniciarse suero glucosalino isosmolar, pero no aparece en las opciones. Se pregunta el primer suero a administrar y el suero glucosado parece la única opción aceptable, ya que es hipotónico. Sin embargo, también está la afirmación: “se corrige primero la volemia y luego, nos preocupamos de los electrolitos” y en ese caso sería correcto el SF, ya que con él se logrará corregir la volemia (con SF o Ringer) y luego corregir la natremia (con suero glucosado). Entonces ante la duda, se responde así: ¿Qué pasa si le doy solo suero glucosado?: se muere; y ¿qué pasa si le soy solo suero fisiológico?: tal vez vive. Por tanto, se elige el suero fisiológico.

### PREGUNTA 4 Respuesta: A

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insuficiencia renal aguda obstructiva" como urgencia clínica (1.09.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

### PREGUNTA 5 Respuesta: E

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es una embolia renal clásica, en contexto de una FA (ritmo irregular). Si no tuviera la FA podría haber sido un cólico renal.

### PREGUNTA 6 Respuesta: B

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

En pacientes que reciben diuréticos (como la furosemida de uso crónico en este caso), la fracción excretada de sodio (FeNa) y el sodio urinario pierden confiabilidad diagnóstica debido a la natriuresis inducida farmacológicamente a nivel del asa de Henle, arrojando falsos positivos de NTA (FeNa > 1% o Na urinario > 20 mEq/L a pesar de hipovolemia). En este escenario clínico específico, la Fracción Excretada de Urea (FeUrea) es el índice de elección, ya que el transporte de urea en el túbulo proximal no se ve directamente afectado por los diuréticos de asa: un FeUrea < 35% confirma origen prerrenal con alta sensibilidad y especificidad.

**PREGUNTA 7** **Respuesta: B**

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El cuadro clínico corresponde a una Necrosis Tubular Aguda (NTA) intrínseca establecida secundaria a shock séptico (isquemia hipóxica prolongada y citotoxicidad mediada por citoquinas proinflamatorias). Los hallazgos confirmatorios son: FeNa marcadamente elevado (> 2%, en este caso 3.2%), oliguria persistente y el sedimento urinario patognomónico con cilindros granulosos oscuros ("muddy brown casts") formados por células tubulares descamadas que se aglutinan en la luz tubular. La respuesta A corresponde a IRA prerrenal pura, descartada por el FeNa > 2% y los cilindros.

**PREGUNTA 8** **Respuesta: C**

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente es monorreno funcional (nefrectomía izquierda previa) y presenta dolor cólico agudo con anuria absoluta. La anuria súbita (débito 0 mL) es el sello de la obstrucción completa de la vía urinaria (litiasis o compresión ureteral en riñón único) o catástrofe vascular. La conducta inicial obligatoria es descartar y resolver la causa postrenal mediante ecografía renal de urgencia (o TAC sin contraste) para constatar hidronefrosis, seguida de la descompresión urológica urgente (nefrostomía percutánea o catéter doble J). Infundir 2 litros de suero (B) en un paciente anúrico obstructivo provocará edema agudo pulmonar.

**PREGUNTA 9** **Respuesta: B**

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Este es el mecanismo clásico de "doble bloqueo hemodinámico" que anula la autorregulación renal: el AINE (Ibuprofeno) bloquea la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras en la arteriola aferente, reduciendo el flujo plasmático que entra al ovillo; paralelamente, el ARA-II (Losartán) bloquea el receptor AT1 de la angiotensina II en la arteriola eferente, impidiendo su vasoconstricción compensatoria. El resultado neto es una caída drástica de la presión hidrostática capilar intraglomerular con colapso de la filtración glomerular, generando una IRA hemodinámica que revierte al suspender ambos fármacos.

**PREGUNTA 10** **Respuesta: E**

**Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)**

1.09.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una nefritis intersticial clásica, con la eosinofilia característica y la insuficiencia renal, probablemente secundaria al tratamiento farmacológico con la cloxacilina (de base tenía una erisipela).

**PREGUNTA 11** **Respuesta: A**

**Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)**

1.09.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Parece una rabdomiólisis, que se estudia con CK.

**PREGUNTA 12** **Respuesta: B**

**Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)**

1.09.2.004, 1.09.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Se trata de una rabdomiólisis por esfuerzo extremo con mioglobinuria masiva y Necrosis Tubular Aguda secundaria. La discordancia clásica del dipstick (tira reactiva que marca sangre 4+ debido a que la ortotolidina reacciona con el grupo hemo de la mioglobina libre) frente a la ausencia de glóbulos rojos en el microscopio certifica la mioglobinuria. El pilar fundamental y urgente del tratamiento es la hidratación intravenosa agresiva con cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico o soluciones balanceadas a 200-300 mL/h) para mantener una diuresis elevada (> 2-3 mL/kg/h) y evitar la precipitación de cilindros de mioglobina y la toxicidad tubular directa.

**PREGUNTA 13** **Respuesta: B**

1.09.2.004, 1.09.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)**

El cuadro corresponde a una Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda inmunoalérgica secundaria a fármacos (el omeprazol y los AINEs son dos de los principales causantes). La presencia de piuria estéril (leucocitos en orina con urocultivo negativo), cilindros leucocitarios y eosinofiluria confirma el diagnóstico. La primera y más importante medida terapéutica es suspender inmediatamente todos los fármacos potencialmente alergizantes (omeprazol y naproxeno). La mayoría de los pacientes recupera la función renal solo con esta medida; los corticoides se reservan si no hay mejoría tras una semana.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

1.09.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)**

El paciente presenta un Edema Pulmonar Agudo con insuficiencia respiratoria severa refractario a dosis altas de diuréticos de asa en el contexto de una falla renal terminal anúrica. Esto corresponde a la "O" (Overload / Sobrecarga de volumen) de los criterios de hemodiálisis de urgencia (AEIOU). Continuar aumentando dosis de diuréticos en un riñón no respondedor solo retrasa el tratamiento definitivo y aumenta la mortalidad; la ultrafiltración inmediata mediante hemodiálisis es la única medida que remueve el exceso de agua y resuelve el edema alveolar.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: B**

1.09.1.023, 1.09.3.004, 1.09.5.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)**

El paciente presenta un Edema Pulmonar Agudo con insuficiencia respiratoria severa refractario a dosis altas de diuréticos de asa en el contexto de una falla renal terminal anúrica. Esto corresponde a la "O" (Overload / Sobrecarga de volumen) de los criterios de hemodiálisis de urgencia (AEIOU). Continuar aumentando dosis de diuréticos en un riñón no respondedor solo retrasa el tratamiento definitivo y aumenta la mortalidad; la ultrafiltración inmediata mediante hemodiálisis es la única medida que remueve el exceso de agua y resuelve el edema alveolar.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: B**

1.09.1.023, 1.09.3.004, 1.09.5.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)**

Se trata de una intoxicación grave por Litio (Litemia > 4.0 mEq/L con neurotoxicidad severa y falla renal aguda). El litio es una molécula pequeña, de bajo peso molecular y baja unión a proteínas plasmáticas, lo que la convierte en una sustancia altamente dializable. Corresponde al criterio "I" (Intoxicaciones dializables: SLIME) de las urgencias dialíticas. El carbón activado (A) no une metales como el litio y no tiene ninguna utilidad.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: C**

1.09.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal**

Prefunta difícil. Tiene un edema por IRC (crea de 2,2) y también por IRC, por lo que la furosemida debería servir. Además, la A, B y D son tiazidas (la indapamida no es una tiazida propiamente tal, pero es cercana), por lo que ninguna es. La E sirve para aumentar la sobrevida en la ICC, pero junto a Enalapril y betabloqueo y en esta pregunta se interroga directamente por el manejo del edema.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: B**

1.09.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal**

El paciente cumple con todos los criterios de Síndrome Hepatorrenal (SHR-IRA): cirrosis con ascitis, deterioro agudo de la función renal, oliguria con sodio urinario muy bajo (< 10 mEq/L), sedimento inactivo y confirmación de refractariedad a la expansión con albúmina intravenosa durante 48 horas. La combinación farmacológica de elección según las guías internacionales (EASL) y nacionales es Terlipresina (análogo sintético de la vasopresina con acción vasoconstrictora esplácnica selectiva) más Albúmina humana IV al 20%, lo que permite recuperar la perfusión renal como puente al trasplante hepático.

---

## BLOQUE 2 TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS) · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome de Secreción Inapropiada de Hormona Antidiurética (SIADH): El caso describe un SIADH clásico con hiponatremia severa y compromiso neurológico. La causa en este caso es el cáncer de pulmón, ya que las alteraciones del sistema nervioso central y las alteraciones pulmonares son las causas más frecuentes de SIADH. Por el compromiso neurológico, se debe tratar con suero hipertónico a pasar muy lento, para evitar la mielinolisis pontina. Si hubiese estado bien, se maneja solo con restricción de agua libre.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Caso clínico oficial EUNACOM para Hiponatremia aguda grave.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica, la conducta médica prioritaria es: Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando 1.6 a 2.0 mEq/L de Na por cada 100 mg/dL de glicemia sobre 100 mg/dL.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La Carbamazepina es un fármaco anticonvulsivante clásico bien conocido por sensibilizar el túbulo colector renal a la vasopresina y estimular la liberación hipotalámica de ADH, desencadenando un SIADH yatrogénico. El paciente presenta la tríada definitoria de SIADH: (1) hiponatremia hipotónica severa (118 mEq/L), (2) estado de euvolemia clínica (sin deshidratación ni edemas), y (3) orina inapropiadamente concentrada (Osmolaridad urinaria 380 mOsm/kg > 100) con natriuresis persistente (Sodio urinario 52 mEq/L > 40) en presencia de función renal y suprarrenal conservadas. El manejo consiste en suspender la carbamazepina y restringir el consumo de agua libre.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: B**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta una encefalopatía hiponatrémica aguda severa con riesgo vital inminente por edema cerebral difuso y enclavamiento encefálico manifestado por coma y convulsiones recurrentes. En este contexto crítico, las guías internacionales y los consensos nefrológicos establecen que la medida de rescate de primera línea es la infusión rápida de un bolo de 100 a 150 mL de Suero Salino Hipertónico al 3% (NaCl 3%) administrado en 20 minutos. Este bolo persigue elevar la natremia en 4 a 6 mEq/L rápidamente, lo cual reduce de inmediato el volumen celular cerebral hipertensivo y detiene las convulsiones. El suero fisiológico al 0.9% es isotónico respecto al plasma normal pero puede ser inefectivo o incluso empeorar la natremia en SIADH grave.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: C**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde al Síndrome de Desmielinización Osmótica (clásicamente conocido como Mielinolisis Pontina Central). Ocurre cuando una hiponatremia crónica severa se corrige a una velocidad excesiva (en este caso el sodio subió 18 mEq/L en 20 horas, violando ampliamente el límite de seguridad de 6–8 mEq/L/día para pacientes alcohólicos desnutridos). Al hipertonizarse bruscamente el plasma, las células cerebrales que habían agotado sus osmolitos orgánicos sufren una deshidratación osmótica masiva que lesiona de manera irreversible los oligodendrocitos pontinos, provocando desmielinización. Clínicamente se manifiesta de 2 a 6 días después de la corrección rápida con disartria, disfagia, paresia pseudobulbar, tetraparesia espástica y estado locked-in.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

Los diuréticos tiazídicos inhiben el cotransportador Na+/Cl- en el túbulo contorneado distal, el cual es el segmento dilutor cortical de la nefrona. Al bloquear este transportador, impiden la generación normal de orina diluida, forzando la excreción de orina hipertónica rica en sodio y potasio. Crucialmente, las tiazidas NO afectan el asa de Henle, por lo que dejan intacto el intersticio medular hiperosmolar renal, permitiendo que la hormona antidiurética (ADH) siga reabsorbiendo agua libre de forma masiva en el túbulo colector. En cambio, los diuréticos de asa bloquean el cotransportador Na+/K+/2Cl- en el asa gruesa de Henle, disolviendo el gradiente medular e impidiendo que el riñón concentre la orina, lo que genera excreción de agua libre y protege paradójicamente contra la hiponatremia.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tiene un probable SSIADH (hiponatremia, con sodio urinario alto). El citalopram puede causarlo.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: A**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Hiponatremia crónica asintomática.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria, la conducta médica prioritaria es: SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu > 100 mOsm/kg) y Nau > 40 mEq/L.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: B**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010, 1.09.2.007 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El cuadro cumple los criterios estrictos de SIADH: hiponatremia hipotónica (127 mEq/L), euvolemia clínica (sin ortostatismo ni edema), sodio urinario alto (60 mEq/L > 40) y osmolaridad urinaria concentrada (520 mOsm/kg > 100) con funciones renal, suprarrenal y tiroidea normales. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (como el Citalopram) son una causa farmacológica frecuente y reconocida de SIADH en adultos mayores al estimular la liberación hipotalámica de hormona antidiurética.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: A**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010, 1.09.2.007 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del pulmón (microcítico u "oat cell") es la neoplasia maligna que con mayor frecuencia causa síndromes paraneoplásicos endocrinos, destacando la secreción ectópica no regulada de hormona antidiurética (vasopresina). Esto desencadena un SIADH clásico con hiponatremia hipotónica euvolémica grave y retención inapropiada de agua libre.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

**Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)**

1.09.1.007 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica)

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: E**

1.09.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)**

Caso clínico oficial EUNACOM para Hipernatremia, poliuria.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

1.09.1.007, 1.09.2.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)**

El uso crónico de sales de litio es la causa adquirida más frecuente de Diabetes Insípida Nefrogénica en la práctica médica y en el examen EUNACOM. El litio penetra a las células principales del túbulo colector renal a través del canal apical de sodio sensible a amilorida (ENaC) e inhibe la adenilil ciclasa y la glucógeno sintetasa kinasa 3-beta (GSK3b), bloqueando la expresión y el tráfico de acuaporinas-2 hacia la membrana apical. Esto vuelve al epitelio tubular impermeable al agua a pesar de niveles plasmáticos normales o elevados de ADH.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

1.09.1.007, 1.09.2.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)**

En un paciente con hipernatremia ya establecida (Na 150 mEq/L) y poliuria hipotónica en contexto de trauma selar o base de cráneo, la prueba de privación de agua está contraindicada por el riesgo de shock y deshidratación letal. El examen indicado es la administración de una dosis de prueba de Desmopresina (DDAVP, 1 a 2 mcg SC o 10 mcg intranasal). Si la osmolaridad urinaria aumenta en más de un 50% a 100% y el volumen urinario desciende drásticamente, se confirma de forma inmediata la Diabetes Insípida Central por déficit de ADH endógena.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: C**

1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica**

En pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada con TFG < 30 mL/min, los diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida) pierden su potencia farmacológica al no alcanzar concentraciones tubulares luminales suficientes en el túbulo distal. En este rango de falla renal, los diuréticos de asa como la Furosemida son los únicos fármacos de primera línea capaces de inducir una natriuresis potente y efectiva para revertir la sobrecarga hídrica, requiriendo frecuentemente dosis más elevadas para compensar la menor carga filtrada.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: B**

1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica**

En la medicina de urgencia existe una regla fisiopatológica inquebrantable: "Frente a un paciente en shock hipovolémico, la prioridad inicial absoluta es restaurar el volumen circulante eficaz y la perfusión orgánica con cristaloides isotónicos, independientemente de la cifra de sodio sérico". Administrar suero glucosado al 5% distribuiría el 92% del volumen administrado fuera del lecho vascular, perpetuando el shock, la isquemia renal y coronaria. Una vez estabilizada la presión arterial media (PAM ≥ 65 mmHg) con SF 0.9% o Ringer Lactato, se procederá a calcular el déficit de agua libre y corregir la hipernatremia lentamente con soluciones hipotónicas.

---

## BLOQUE 3 TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: C**

1.09.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

Gluconato de calcio endovenoso

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: C**

1.09.2.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

En toda hiperkalemia grave acompañada de alteraciones electrocardiográficas (bradicardia extrema, QRS ancho u ondas T picudas), la regla de oro internacional es estabilizar de inmediato la membrana celular de los cardiomiocitos para impedir la fibrilación ventricular o asistolia letal. El fármaco de elección absoluta es el Gluconato de Calcio al 10% intravenoso. Su efecto protector es casi instantáneo (1 a 3 minutos). Las medidas para redistribuir el potasio (insulina con glucosa) o para eliminarlo (hemodiálisis) deben coordinarse de inmediato, pero NUNCA deben anteponerse a la administración del calcio.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

1.09.2.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

Una vez estabilizada la membrana miocárdica con calcio, la fase terapéutica inmediata es el desplazamiento intracelular rápido ("shifting") del potasio plasmático. La medida más potente y rápida es la infusión de 10 Unidades de Insulina Rápida (regular o cristalina) combinada con glucosa hipertónica (ej. 100 mL de SG al 30% o 250 mL al 10%) para prevenir la hipoglicemia. La insulina estimula la bomba Na+/K+-ATPasa ingresando potasio a las células en 15 a 30 minutos. Las resinas de intercambio catiónico (A) tardan varias horas en hacer efecto y no son apropiadas para el rescate agudo.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: C**

1.09.2.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

En un paciente con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis que omite su sesión de filtración, la retención de potasio es constante y predecible. Las manifestaciones clínicas clásicas de la hiperkalemia grave combinan dos esferas principales: la electrofisiología cardíaca (bradicardia, bloqueos AV y arritmias) y el sistema neuromuscular (debilidad muscular profunda, astenia, tetraparesia flácida ascendente e hiporreflexia que simula una parálisis periódica o un síndrome de Guillain-Barré). El diagnóstico es hiperkalemia grave y requiere ECG y tratamiento de urgencia inmediatos.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: C**

1.09.2.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

La presencia de una hiperkalemia significativa en un paciente clínicamente asintomático, sin factores de riesgo conocidos de falla renal o ingesta de fármacos retenedores de potasio, y con un electrocardiograma completamente normal, orienta con fuerza a una Pseudohiperkalemia. Ésta se produce por la liberación in vitro de potasio intracelular tras la extracción sanguínea, típicamente por hemólisis traumática por torniquete prolongado, o por desgranulación de plaquetas en pacientes con trombocitosis marcada (> 500.000/uL). La conducta adecuada es confirmar el hallazgo mediante una nueva toma de muestra venosa atraumática sin torniquete o gasometría arterial con electrolitos antes de instaurar tratamientos potencialmente dañinos.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

1.09.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 140). Evalúa el manejo clínico de Hipokalemia según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

1.09.2.006, 1.09.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio**

La hipokalemia es el principal factor facilitador de la toxicidad e intoxicación por digitálicos (digoxina). El potasio y la digoxina compiten por el mismo sitio de unión en la subunidad alfa extracelular de la bomba Na+/K+-ATPasa del miocito. Cuando existe hipokalemia, la digoxina se une de forma masiva y prolongada a la bomba, intensificando drásticamente su inhibición enzimática y desencadenando arritmias ventriculares graves potencialmente mortales (taquicardia ventricular bidireccional, fibrilación ventricular). Por ello, en pacientes usuarios de digoxina, la kalemia debe mantenerse rigurosamente sobre 4.0 mEq/L.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: A**

1.09.2.006, 1.09.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio**

Las directrices clínicas estandarizadas de farmacoterapia intravenosa establecen que por vía venosa periférica la concentración de cloruro de potasio (KCl) no debe sobrepasar los 40 mEq por litro de solución (para evitar el dolor intenso, espasmo vascular y flebitis química) y el ritmo de infusión no debe superar los 10 a 20 mEq por hora. Para velocidades o concentraciones mayores se requiere acceso venoso central bajo monitorización continua.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

Acidosis metabólica con anión gap normal: El diagnóstico es acidosis metabólica, ya que el bicarbonato está bajo con un anión gap normal (entre 8 y 12). El anion gap se eleva en las demás opciones, ya que refleja la acumulación de ácidos orgánicos. En este caso, la causa es la misma falla renal.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: B**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

Es una pregunta muy discutible y que no tiene una respuesta clara. Tiene una insuficiencia renal, con hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. De las complicaciones, la hiperkalemia es la más urgente de mejorar, por el riesgo de evolucionar a una arritmia maligna, pero, por lo general, el gluconato de calcio solo está indicado si hay compromiso electrocardiográfico o si el potasio está sobre 7 mEq/L. La acidosis sí se debe tratar con bicarbonato de sodio, ya sea EV o VO, dependiendo del pH (en este caso no lo dan, pero por el nivel de bicarbonato parece candidato a EV). Las diálisis solo se indican si es que tiene un síndrome urémico o una complicación grave y refractaria al tratamiento médico. Como se pregunta la conduta inicial, en conjunto con varios especialistas, asumimos que la respuesta es el gluconato de calcio, para el manejo de la hiperkalemia, pero insistimos en que es una pregunta mala.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

1.09.1.001, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

En las etapas intermedias de la Enfermedad Renal Crónica (estadios G3 a G4 con TFG entre 20 y 45 mL/min), la acidosis metabólica característica es típicamente con Anion Gap Normal (hiperclorémica). Esto se debe a que la reducción de la masa de nefronas funcionantes disminuye la amoniagénesis tubular proximal (síntesis de buffer amonio $NH4+$), limitando la excreción neta de protones mientras el riñón reabsorbe cloro para mantener la electroneutralidad. La acidosis con Anion Gap Elevado solo aparece en etapas terminales (G5 o TFG < 15 mL/min) cuando se acumulan fosfatos, sulfatos y uratos.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: B**

1.09.1.001, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

La paciente presenta una acidosis metabólica severa con Anion Gap marcadamente elevado: AG = 140 - (96 + 7) = 37 mEq/L. Calculando la osmolaridad plasmática: 2 x 140 + 90/18 + 14/2.8 = 280 + 5 + 5 = 290 mOsm/kg. La Brecha Osmolar (Osmolar Gap) es: 330 - 290 = 40 mOsm/kg (muy superior al valor normal de 10 mOsm/kg), lo que certifica la presencia de un alcohol de bajo peso molecular. La queja de visión borrosa "en tormenta de nieve" con hiperemia de papila óptica es patognomónica de la toxicidad ocular del ácido fórmico, metabolito tóxico del Metanol. Requiere Fomepizol o etanol y hemodiálisis urgente.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

1.09.1.001, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

La fórmula de Winter predice la $pCO2$ compensatoria en acidosis metabólica: $pCO2 = 1.5 \times [HCO3] + 8 \pm 2$. Con un bicarbonato de 10 mEq/L: 1.5 x 10 = 15; sumando 8 da 23 mmHg. El rango de compensación respiratoria fisiológica pura es de 21 a 25 mmHg. Si la $pCO2$ fuera mayor a 25 mmHg se diagnosticaría acidosis respiratoria concomitante; si fuera menor a 21 mmHg, alcalosis respiratoria asociada.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: B**

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

1.09.1.001, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El consenso de las guías internacionales (Surviving Sepsis Campaign, guías KDIGO y ADA) reserva el uso de bicarbonato de sodio intravenoso exclusivamente para situaciones críticas con pH sanguíneo < 7.10 o bicarbonato < 6 a 8 mEq/L refractario, especialmente cuando condiciona inestabilidad hemodinámica o refractariedad a vasopresores. En pH > 7.15 (como en las opciones A y C), el bicarbonato no mejora la supervivencia y conlleva graves riesgos de acidosis intracelular paradójica, hipocalcemia y sobrecarga de volumen.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

1.09.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Acidosis metabólica" (1.09.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: A**

**Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos**

1.09.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Alcalosis metabólica" (1.09.1.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

**Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos**

1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta una alcalosis metabólica salino-responsiva (sensible a cloro) clásica inducida por vómitos, con cloro urinario suprimido (< 20 mEq/L, en este caso 6 mEq/L), hipocloremia profunda e hipokalemia. El tratamiento de elección consiste en expandir el volumen extracelular y aportar cloro mediante la administración de Suero Fisiológico al 0.9% suplementado con Cloruro de Potasio (KCl). El aporte de cloro permite al cotransportador pendrina del túbulo colector intercambiar bicarbonato luminal por cloro, eliminando el bicarbonato en la orina y normalizando el pH de manera rápida y segura.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: A**

**Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos**

1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La combinación de hipertensión arterial resistente de inicio en adulto joven o medio, hipokalemia espontánea persistente y alcalosis metabólica con Cloro Urinario elevado (> 20 mEq/L, salino-resistente) es el cuadro arquetípico del Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn). La secreción autónoma de aldosterona estimula de forma incesante los canales ENaC y las bombas H+-ATPasa en el túbulo colector cortical, forzando la excreción masiva de potasio y protones mientras retiene sodio y expande el volumen extracelular provocando hipertensión arterial.

---

## BLOQUE 4 SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Proteinuria**

1.09.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es normal la proteinuria con el ejercicio intenso. No tiene clínica de rabdomiolisis

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Proteinuria masiva (>3.5 g/24h) + hipoalbuminemia + edema + sin hematuria = síndrome nefrótico puro. En adulto joven sin causa secundaria, la causa más frecuente es nefropatía por cambios mínimos.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El síndrome nefrótico con hipoalbuminemia severa (< 2.5 g/dL) confiere un estado de hipercoagulabilidad severo debido a la pérdida urinaria selectiva de anticoagulantes endógenos fisiológicos, principalmente la Antitrombina III (AT-III), sumada a la hiperfibrinogenemia reactiva hepática. Esta alteración predispone de forma catastrófica a trombosis venosa profunda, trombosis de la vena renal y tromboembolismo pulmonar (TEP). El dolor pleurítico súbito con disnea e hipoxemia en este paciente traduce un TEP agudo.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

En todo paciente adulto que debuta con un síndrome nefrótico primario, la Biopsia Renal Percutánea es la conducta diagnóstica de elección obligatoria e insustituible. A diferencia de los niños, en quienes la gran mayoría padece enfermedad por cambios mínimos y se trata empíricamente con corticoides, en los adultos el espectro histológico es sumamente heterogéneo (membranosa, FSGS, cambios mínimos, amiloidosis) y los tratamientos inmunosupresores específicos difieren radicalmente según el patrón anatomopatológico.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente cumple rigurosamente con los criterios de Síndrome Nefrótico Puro: proteinuria en rango nefrótico masivo (> 3.5 g/24 h), hipoalbuminemia marcada (< 3.0 g/dL) y edema clínico, en ausencia total de elementos inflamatorios nefríticos (sin hematuria dismórfica, sin hipertensión arterial y sin cilindros hemáticos). En adultos jóvenes, las causas primarias más comunes son la nefropatía por cambios mínimos o la glomeruloesclerosis focal y segmentaria.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La lipiduria es una consecuencia directa de la filtración glomerular masiva de lipoproteínas en el síndrome nefrótico. Las células del epitelio tubular proximal endocitan estas grasas y al descamarse se observan como cuerpos ovales grasos en la orina. Al ser examinadas bajo luz microscópica polarizada, los ésteres de colesterol presentan una birrefringencia anisotrópica característica en forma de cruz, conocida clásicamente como la "Cruz de Malta", hallazgo distintivo y confirmatorio de síndrome nefrótico.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones:" como urgencia clínica (1.09.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: E**

**Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa**

1.09.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde a un Síndrome Nefrótico Puro en un adulto mayor de 60 años (proteinuria masiva de 7 g/24 h con sedimento urinario inactivo, sin hematuria glomerular). En este grupo etario, la causa más frecuente es la Nefropatía Membranosa. Todas las demás opciones planteadas (Berger, lupus, GNPE, vasculitis) cursan típicamente con síndrome nefrítico o glomerulonefritis proliferativa con hematuria dismórfica intensa, cilindros hemáticos y deterioro inflamatorio renal agudo.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A**

**Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa**

1.09.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Aproximadamente un 20 a 25% de las nefropatías membranosas del adulto son secundarias. Cuando los anticuerpos anti-PLA2R son negativos en un adulto mayor de 50 años, la sospecha de una etiología secundaria se eleva sustancialmente, siendo la principal causa el origen paraneoplásico por tumores sólidos ocultos (carcinoma pulmonar, de colon, gástrico o de mama) o infecciones virales crónicas (Hepatitis B). El estudio de extensión tumoral y serológico es un mandato prioritario.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)**

1.09.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

B? Tiene un glomerulonefritis aguda postestreptocócica, con un síndrome nefrítico y una insuficiencia cardiaca, por la crisis hipertensiva. Dada la sobrecarga de volumen, la furosemida ev parece ser el tratamiento más razonable, pero el captopril también po- dría ser de utilidad.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)**

1.09.1.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde a una Glomerulonefritis Postestreptocócica complicada con sobrecarga de volumen severa y emergencia hipertensiva (PA 180/110 mmHg con crepitaciones pulmonares bibasales por congestión venocapilar). Al tratarse de una enfermedad mediada por inmunocomplejos autolimitada, el objetivo terapéutico inmediato es revertir la expansión del volumen extracelular mediante el uso de diuréticos de asa (furosemida endovenosa) y restricción hidrosalina estricta. El uso de antibióticos no modifica el curso del daño glomerular una vez instalado, y los corticoides no están indicados en las formas típicas de GNPE.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)**

1.09.1.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La presencia de macrohematuria glomerular inmediatamente contemporánea o a las 24–48 horas del inicio de una infección respiratoria alta ("hematuria sinfaringítica") en un adulto joven, con presión arterial normal y niveles de complemento sérico C3 y C4 completamente normales, es el sello distintivo indiscutible de la Nefropatía por IgA (Enfermedad de Berger). En la GNPE, la latencia habría sido de 1 a 2 semanas y el C3 estaría descendido.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: B**

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

1.09.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene los siguientes diagnósticos: insuficiencia renal aguda, síndrome nefrítico, glomerulonefriGs rápidamente progresiva (GNRP) e hipertensión secundaria. La principal sospecha es una micropoliangeíGs o poliangeíGs microscópica (PAM), que es una vasculiGs grave (alta letalidad sin tratamiento), clásica del adulto mayor. Es ANCA positivo en patrón perinuclear (ANCA-p). Biopsia renal y ANCA aparecen como opciones adecuadas, pero la pregunta específica es el examen adecuado para “confirmar el diagnóstico”, por lo que la respuesta correcta es la biopsia renal (examen de elección para el estudio de las GNRP). Sin embargo, es posible que quien redactó la pregunta haya intentado preguntar los ANCA, evaluando la capacidad de identificar el cuadro clínico. Se trata con corticoides sistémicos más rituximab (más usado hoy) o ciclofosfamida. Las recurrencias se evitan con rituximab.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: B**

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

1.09.2.013, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente presenta una sospecha indudable de Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) con falla renal acelerada y síndrome nefrítico grave. La Biopsia Renal Percutánea es el examen de referencia (gold standard) imprescindible y obligatorio, ya que permite documentar la presencia y porcentaje de semilunas epiteliales (> 50% confirma GNRP), evaluar el grado de cronicidad fibrocelular versus celularidad activa, y mediante la inmunofluorescencia catalogar de inmediato el tipo específico (anti-MBG lineal, inmunocomplejos granular o pauciinmune) para normar el tratamiento inmunosupresor de emergencia.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: D**

1.09.2.013, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

El cuadro corresponde a una vasculitis necrosante de pequeños vasos asociada a ANCA (como la poliangeítis microscópica o granulomatosis con poliangeítis), que debuta clásicamente en adultos mayores como una glomerulonefritis rápidamente progresiva con síndrome nefrítico e hipertensión secundaria severa. La serología con ANCA positivo y la ausencia de consumo de complemento diferencian con claridad esta entidad de la GN postestreptocócica y del lupus.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: A**

1.09.2.013, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

El paciente presenta el cuadro clásico del Síndrome de Goodpasture (Enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular) manifestado como síndrome riñón-pulmón (hemorragia alveolar difusa con hemoptisis e insuficiencia renal rápidamente progresiva por GN extracapilar con semilunas). El depósito lineal de IgG en la membrana basal glomerular es patognomónico. El tratamiento de urgencia vital es la combinación sinérgica de: (1) Plasmaféresis diaria para remover los anticuerpos circulantes anti-MBG; (2) Pulsos de Metilprednisolona IV para yugular la inflamación celular; y (3) Ciclofosfamida para inhibir la síntesis de nuevos anticuerpos.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: A**

1.09.2.013, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

El porcentaje de semilunas epiteliales celulares activas versus semilunas fibrocelulares o fibrosas en la biopsia renal es el determinante pronóstico de recuperabilidad más importante. Las semilunas celulares corresponden a proliferación e inflamación activa potencialmente reversibles con terapia inmunosupresora agresiva. En cambio, las semilunas fibrosas con fibrosis intersticial y atrofia tubular avanzada traducen esclerosis terminal irreversible, con nula respuesta a fármacos citotóxicos y evolución inevitable a diálisis crónica.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

1.09.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica**

Es un lupus sistémico clásico, con afectación renal.

---

## BLOQUE 5 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** **Bacteriuria asintomática** 1.09.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Bacteriuria asintomática" (1.09.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** **Progresión de la IRC** 1.09.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Progresión de la IRC" (1.09.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: A** **Riñón poliquístico** 1.09.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Riñón poliquístico" (1.09.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A**

**Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas**

1.09.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas" como urgencia clínica (1.09.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: A** **Pre eclampsia**

1.09.2.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Pre eclampsia" como urgencia clínica (1.09.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: A**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hipertensión arterial esencial" (1.09.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: C**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tanto por la PA (mayor a 130/80 dice la guía antigua, sin embargo la nueva lo deja en 140/90), como por la proteinuria positiva (IP/ C mayor a 0,2 es proteinuria). La proteinuria hace que sea 100% segura la opción de darle los IECAS.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: C**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En todo paciente diabético que presenta microalbuminuria o proteinuria confirmada (RAC ≥ 30 mg/g o IPC ≥ 0.2), las guías clínicas ministeriales (MINSAL) e internacionales (ADA / KDIGO) establecen que el fármaco antihipertensivo y nefroprotector de elección obligada es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA, como el Enalapril) o un antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA-II, como el Losartán). Los IECA vasodilatan la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión hidrostática intraglomerular y frenando la progresión de la nefropatía diabética.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: A**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta una Enfermedad Renal Crónica confirmada en Etapa 4 (TFG entre 15 y 29 mL/min, en este caso 24 mL/min). En Chile, el Problema de Salud GES N° 1 cubre formalmente la ERC en Etapas 4 y 5. La obligación del médico de atención primaria es notificar el caso al sistema GES y emitir la derivación al especialista Nefrólogo en el nivel secundario, quien tiene un plazo garantizado por ley de no más de 30 días para evaluar a la paciente, optimizar el manejo metabólico, vacunar contra hepatitis B y planificar la confección oportuna del acceso vascular (fístula arteriovenosa) pre-diálisis.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: A**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Una fístula arteriovenosa (FAV) autóloga requiere someterse al flujo de alta presión pulsátil arterial para que la vena anastomosada se dilate progresivamente, engruese su capa muscular y endotelial ("arterialización") y alcance un calibre y flujo suficientes (> 500–600 mL/min) que permitan soportar punciones repetidas con agujas de diálisis de grueso calibre. Este proceso biológico de maduración vascular tarda típicamente entre 2 a 6 meses. La confección precoz evita que el paciente deba ingresar a diálisis de urgencia con un catéter venoso central transitorio, el cual se asocia a bacteriemias letales y estenosis venosa central.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECA o ARA-II produce una vasodilatación de la arteriola eferente que alivia la hiperfiltración e hipertensión intraglomerular, lo cual genera de manera hemodinámica esperable una discreta disminución del filtrado glomerular reflejada en una elevación leve de la creatinina sérica. Se considera un efecto fisiológico seguro y tolerable si el aumento de la creatinina sérica es menor al 30% respecto al valor basal y la kalemia se mantiene en niveles seguros (< 5.5 mEq/L). Por tanto, con un ascenso del 18% y potasio normal, la conducta correcta es mantener el fármaco y monitorear.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: A**

**Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis**

1.09.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Anemia en nefrópata" (1.09.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: A**

**Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis**

1.09.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal. Si bien la calciuria de 24 horas permite ver el grado de pérdida de calcio diario, lo más importante será determinar los niveles de vitamina D, ya que tanto la falla renal, como el hiperparatiroidismo mismo disminuyen sus niveles, agravando la osteodistrofia. Al medirla, se puede observar el déficit, de modo de indicar suplementos de vitamina D y, además, permite descartar el déficit primario de vitamina D, como causa del HPP.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: D**

**Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal**

1.09.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una HTA renovascular clásica, tanto por el soplo renal, como por la clínica de hipertensión secundaria (joven, severa),

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: A**

**Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto**

1.09.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Infección urinaria baja (cistitis)" (1.09.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: C**

1.09.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 70). Evalúa el manejo clínico de Pielonefritis aguda no complicada según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: D**

1.09.2.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto**

Pielonefritis aguda en el embarazo: El cuadro clínico y el sedimento de orina sugieren pielonefritis aguda. Durante el embarazo, las pielonefritis requieren hospitalización y tratamiento con antibióticos intravenosos, generalmente cefalosporinas. Se recomienda la tercera generación (ceftriaxona), aunque también se pueden usar de primera generación. El ciprofloxacino está contraindicado en el embarazo. La nitrofurantoína solo es efectiva para infecciones urinarias bajas. La amoxicilina/ácido clavulánico y la ampicilina no se recomiendan en el tratamiento de infecciones urinarias.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

1.09.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Insuficiencia renal crónica" (1.09.1.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---